

# Démarches anticipées en vue de don d'organes et de tissus

Démarches anticipées en vue de don d'organes et de tissus



**Champ** : patients en coma grave (Glasgow < 8) sans perspective thérapeutique après lésion cérébrale irréversible (AVC hémorragique/ischémique, traumatisme crânien), **avant** la survenue d'une mort cérébrale — admission en réanimation dans le seul but d'un possible don d'organes/tissus. Distinct de la prise en charge d'un donneur **déjà** en mort encéphalique (fiche dédiée « Mort encéphalique et prélèvement d'organes », SFAR/SRLF/ABM 2005).

AF

**AF = Accord Fort / AF- = Accord Faible** — cotation à deux tours inspirée de RAND/UCLA (échelle continue 1-9, 3 zones : désaccord 1-3, indécision 4-6, accord 7-9 ; « fort » si la médiane reste dans une zone, « faible » si elle empiète sur une borne). 29 blocs à accord fort, **1 seul bloc à accord faible** (étape 1, conduite en cas de défaillance vitale immédiate) — jamais fusionnés. Sigles AF/AF- introduits par cette fiche : le texte source imprime les mots en toutes lettres après chaque bloc concerné.

**Repères (glossaire du texte source) :**

- **Donneur possible** : patient avec dommage cérébral, signe de gravité (Glasgow < 8), sans contre-indication médicale d'emblée, avec ≥ 1 organe prélevable.
- **Donneur potentiel** : donneur possible avec clinique de mort cérébrale (constatée ou probable).
- **CHPOT** : coordination hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus.
- **Services partenaires** : urgences, neurologie/USINV, autres USIP, médecine/chirurgie — de l'établissement ou de son réseau opérationnel de proximité (ROP).

## I — Prérequis à la mise en place d'une démarche anticipée

| §   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                              | Cotation |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I.1 | La mise en place des démarches anticipées dans un établissement doit s'accompagner d'une réflexion institutionnelle préalable sur l'information et la formation des professionnels.                                                         | AF       |
| I.2 | La CHPOT identifie les services partenaires où elles pourront être mises en place, dans son établissement et son réseau opérationnel de proximité (ROP).                                                                                    | AF       |
| I.3 | La CHPOT, les services partenaires et la réanimation élaborent et formalisent une procédure locale (algorithme, checklist, livret d'information) définissant collégialement les critères d'admission des donneurs possibles en réanimation. | AF       |
| I.4 | En cas de transfert interhospitalier du donneur possible, les frais de retour du corps sont à la charge de l'établissement autorisé au prélèvement où le décès a été déclaré, qu'il y ait eu ou non prélèvement.                            | AF       |

## II — Définitions

| §    | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cotation |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| II.1 | La <b>démarche anticipée</b> est un processus conduisant à l'admission en réanimation d'un patient en coma grave sans perspective thérapeutique, à forte probabilité d'évolution vers la mort cérébrale, à finalité exclusive de possible prélèvement — collaboration pluridisciplinaire, étapes successives, accompagnement de fin de vie. | AF       |
| II.2 | L' <b>entretien anticipé</b> est un entretien soignants-proches pour évoquer en amont la possibilité du don post mortem et recueillir l'éventuelle expression d'un refus du patient et l'adhésion des proches. Le terme « abord anticipé » ne doit plus être utilisé.                                                                       | AF       |

## III — Prérequis cliniques à une démarche anticipée

| §     | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cotation |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| III.1 | Deux prérequis : (1) une décision de limitation des traitements actée collégialement, après avis d'expert(s) (neurochirurgien/neurologue/réanimateur), devant l'absence de perspective thérapeutique (lésions cérébrales irréversibles, coma grave Glasgow < 8 ou d'aggravation rapide) ; (2) l'annonce de la gravité, du pronostic vital engagé et de la mort à venir déjà réalisée par le médecin du service partenaire, avec vérification de sa compréhension par les proches. | AF       |

## IV — Étape 1 : Repérage d'un donneur possible

# Démarches anticipées en vue de don d'organes et de tissus

Démarches anticipées en vue de don d'organes et de tissus



| §   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cotation |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1 | Un donneur possible : lésions cérébrales irréversibles (AVCH, AVCI ou traumatisme crânien) ; coma grave (Glasgow < 8 ou aggravation rapide) ; sans perspective thérapeutique après avis d'expert(s) en concertation avec l'équipe de soins.                                                                                                                                                                                                                           | AF       |
| 1.2 | Patient non ventilé, <b>sans</b> défaillance vitale immédiate : toutes les étapes de la démarche avant l'éventuelle admission en réanimation/gestes invasifs. Patient <b>avec</b> défaillance vitale immédiate cardio-respiratoire : gestes invasifs (dont intubation) envisageables de façon collégiale dans l'attente du recueil d'une éventuelle opposition ; dans tous les cas, soulagement des souffrances et accompagnement de fin de vie restent prioritaires. | AF-      |
| 1.3 | Ce repérage déclenche l'appel à la CHPOT. Le service partenaire ne se prononce pas seul sur une contre-indication ou une limite d'âge, sans concertation avec la CHPOT.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AF       |
| 1.4 | Situations particulières : préhospitalier — aucun entretien pour le don, seule l'évaluation du contexte clinique est possible. Réanimation sous ventilation invasive — entretien après le diagnostic de mort cérébrale (présence CHPOT recommandée), sauf cheminement particulier des proches. Réanimation sans ventilation invasive — toutes les étapes de la démarche.                                                                                              | AF       |

## Étape 2 : Appel à la CHPOT

| §   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cotation |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2.1 | Dès le premier appel à la CHPOT, le déplacement d'un soignant CHPOT sur site dans le service partenaire est recommandé.                                                                                                                                                                                                                                 | AF       |
| 2.2 | Évaluation du donneur possible : estimation de la probabilité de mort cérébrale, vérification de l'absence de contre-indication absolue (dossier médical, médecin traitant), vérification de la prélevabilité d'au moins un organe (bilan biologique rénal/hépatique minimal) ; le régulateur de l'Agence de la biomédecine peut être appelé pour avis. | AF       |
| 2.3 | Vérification de l'organisation logistique (recherche d'un lit de réanimation, anticipée à l'échelle de l'établissement/réseau régional). L'entretien anticipé avec les proches est possible à ce stade.                                                                                                                                                 | AF       |

## Étape 3 : Entretiens avec les proches — Objectifs

| §   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cotation |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.1 | Vérification de la compréhension par les proches de la gravité, du pronostic vital engagé, de l'absence de perspective thérapeutique et de la mort à venir avec forte probabilité d'évolution vers la mort cérébrale.                                                                                                                                                                                                                           | AF       |
| 3.2 | Information sur la possibilité du don après la mort et recueil de l'éventuelle expression d'un refus du patient (= l'entretien anticipé). Le registre national des refus (RNR) ne peut être interrogé qu'après la déclaration de décès.                                                                                                                                                                                                         | AF       |
| 3.3 | En l'absence d'opposition rapportée : information sur les modalités organisationnelles (transfert en réanimation, gestes spécifiques dont l'intubation, continuité de l'accompagnement), la durée d'hospitalisation en réanimation (habituellement 3 à 6 jours, à l'issue de laquelle la mort surviendra après arrêt des traitements de maintien en vie en l'absence de mort cérébrale), et la possibilité de non-aboutissement de la démarche. | AF       |
| 3.4 | Vérification de l'adhésion des proches à la démarche anticipée ; la situation est réévaluée avec eux selon leur vécu et l'évolution clinique du patient.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AF       |

## Étape 3 : Spécificités pratiques de l'entretien anticipé

| §   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cotation |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.5 | <b>Qui</b> : un binôme — médecin sénior (service partenaire et/ou réa, le plus expérimenté) + soignant CHPOT (systématique en ES autorisés au prélèvement, privilégié dans les ES du ROP), éventuellement accompagné de paramédical(aux) ; équilibre à respecter entre nombre de proches et de soignants ; recours à un(e) psychologue souhaitable. | AF       |
| 3.6 | <b>Où</b> : salle à proximité du lieu de prise en charge, aménagée pour recevoir l'ensemble des proches et soignants, confortable, calme, dédiée.                                                                                                                                                                                                   | AF       |

# Démarches anticipées en vue de don d'organes et de tissus



Démarches anticipées en vue de don d'organes et de tissus

| §   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                              | Cotation |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3.7 | <b>Quand</b> : adaptation au cheminement des proches et à l'état clinique du patient, en respectant l'ordre des étapes ; un entretien en journée est à privilégier.                                                                                                         | AF       |
| 3.8 | <b>Comment</b> : transparence des informations et incertitude de l'aboutissement à concilier ; préparation entre soignants (mise en commun des informations, rôle de chacun, objectifs communs) ; la CHPOT reste disponible pour les questions spécifiques au prélèvement.  | AF       |
| 3.9 | <b>Traçabilité</b> : synthèse de l'entretien tracée au dossier ; évaluation via une grille de débriefing (temporalité, compréhension des proches, présence CHPOT...) ; une opposition transmise par un proche est retranscrite au dossier par la coordination hospitalière. | AF       |

## Étape 4 : Transfert et accueil en réanimation

| §   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cotation |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.1 | L'ensemble des étapes est tracé au dossier patient. Le transfert vers la réanimation est médicalisé ; tous les soignants sont informés des objectifs de l'admission (accompagnement de fin de vie et réanimation d'organes en vue d'un éventuel prélèvement).                                                                  | AF       |
| 4.2 | La présence des proches est facilitée dans ce contexte de fin de vie ; l'accompagnement des proches et la réévaluation de la poursuite de la démarche sont assurés par la réanimation en partenariat avec la CHPOT.                                                                                                            | AF       |
| 4.3 | Le soulagement des souffrances réelles ou potentielles est assuré pendant le séjour, même non évaluables du fait de l'état neurologique (article R4127-37-3 CSP). En l'absence d'évolution vers la mort cérébrale, un arrêt des traitements de maintien en vie est mis en œuvre selon le protocole du service, jusqu'au décès. | AF       |

## V — Formation des professionnels de santé

| §   | Recommandation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cotation |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| V.1 | Les médecins impliqués sont invités aux formations régionales de l'Agence de la biomédecine sur les entretiens avec les proches. Les professionnels de coordination hospitalière bénéficient d'un parcours de formation continue avec l'Agence ; leur participation aux étapes de la démarche est indispensable. Toutes les formations abordent les principes généraux des entretiens, certaines incluant les démarches anticipées. | AF       |

## Sources et avertissement

Agence de la biomédecine, « Recommandations de bonne pratique relatives aux démarches anticipées en vue de don d'organes et de tissus », méthode RPC (HAS), septembre 2024. Cotation RAND/UCLA à 2 tours par un groupe de travail d'experts, après synthèse bibliographique et relecture par un groupe de lecture de 34 membres référents ; avis favorable du conseil d'orientation de l'ABM le 19/09/2024. 52 références bibliographiques citées dans le texte intégral (non reproduites ici).

**Avertissement** : cette fiche est une synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend intégralement les recommandations des 5 sections du texte source (I à V) mais condense l'introduction, la situation de la problématique et omet la liste nominative des groupes de travail/lecture. Elle ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par l'Agence de la biomédecine.